

[D'APRÈS LES RECOMMANDATIONS ESC 2024 & LA MASTERCLASS MEDILEARN]

200/110

mmHg

HYPERTENSION ARTÉRIELLE : DÉMYSTIFIER LE CHIFFRE

Algorithmes thérapeutiques, nouveaux standards
et gestion des crises.

Le mythe de la salle d'attente : un réflexe potentiellement fatal

Patient asymptomatique
en salle d'attente.
Pression mesurée :
200/110 mmHg.



LE RÉFLEXE : FAIRE CHUTER LA PA BRUTALEMENT.

Risque d'hypoperfusion et
d'Accident Vasculaire Cérébral
(AVC) massif par ischémie.

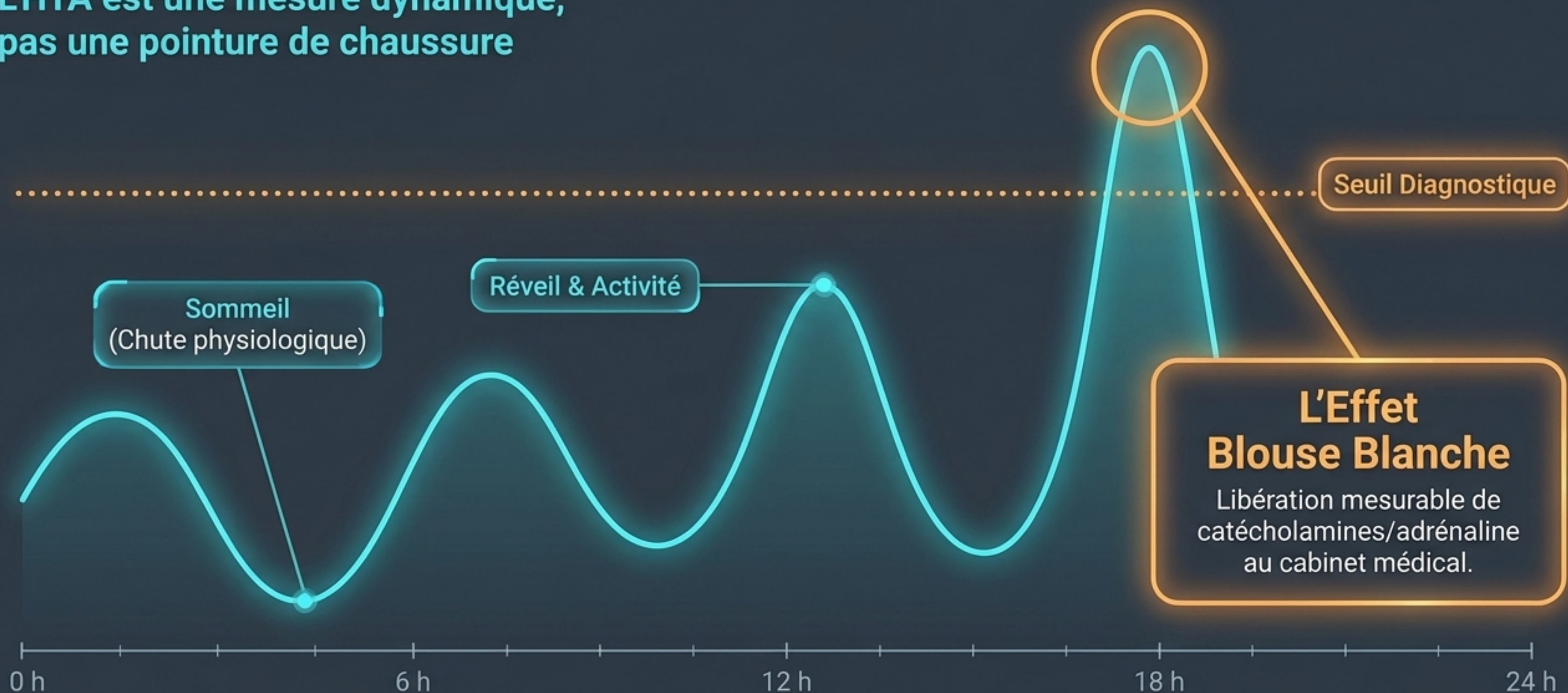


LA RÉALITÉ CLINIQUE.

L'urgence est dictée par la
souffrance de l'organe, pas par
le tensiomètre.

« Ce qui semble être un geste de sauvetage peut se transformer
en catastrophe neurologique. »

L'HTA est une mesure dynamique,
pas une pointure de chaussure



Le diagnostic d'HTA exige une élévation PERSISTANTE confirmée par plusieurs mesures, hors situation d'urgence vitale.

Les véritables seuils diagnostiques (ESC 2024)



**Cabinet
médical**

$\geq 140/90$
mmHg



**Automesure
(Domicile)**

$\geq 135/85$
mmHg



**MAPA
(24 heures)**

$\geq 130/80$
mmHg
(Inclut la baisse nocturne)

NOUVEAUTÉ ESC 2024 :
La « Pression Artérielle Élevée »

- **PAS** 120–139 mmHg et/ou **PAD** 70–89 mmHg.
- **Signal d'alarme précoce** pour agir sur le mode de vie avant les lésions artérielles irréversibles. (Pas de surmédicalisation).

La classification classique : évaluer l'intensité



HTA Grade 3 (Sévère)

PAS ≥ 180 ou PAD ≥ 110

HTA Grade 2

PAS 160–179
ou PAD 100–109

HTA Grade 1

PAS 140–159
ou PAD 90–99

Le grade final est toujours déterminé par la valeur **la plus élevée** (systolique OU diastolique).

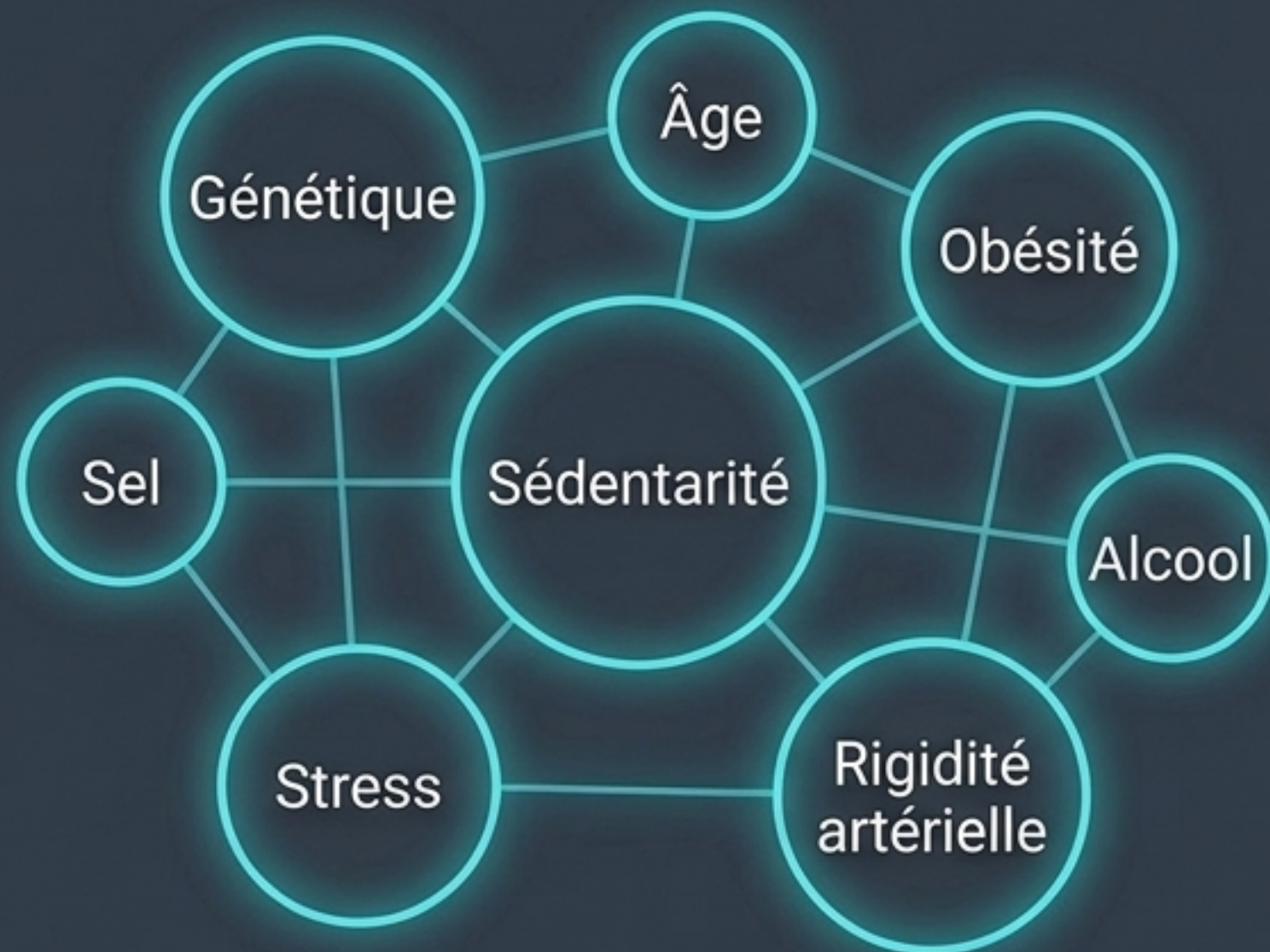


Rappel : 180 mmHg n'est PAS le seuil diagnostique de l'HTA, c'est le marqueur de l'HTA sévère (Grade 3).

Réévaluation de l'étiologie : la cause secondaire n'est plus une rareté

HTA Primaire / Essentielle

Pas de maladie unique. Multifactorielle.



HTA Secondaire

Provoquée par une maladie ou substance identifiable.



Jusqu'à **50 %** dans certaines HTA résistantes.

Le socle universel : les mesures hygiéno-diététiques



L'arsenal pharmacologique de première ligne

1. IEC

(Inhibiteurs de l'enzyme de conversion)

Ex: Ramipril, Périndopril

2. ARA-II

(Antagonistes des récepteurs AT1)

Ex: Valsartan, Candesartan

RÈGLE ABSOLUE : Un IEC et un ARA-II ne doivent JAMAIS être associés entre eux.

3. Inhibiteurs Calciques

(Dihydropyridiniques)

Ex: Amlodipine

4. Diurétiques

(Thiazidiques / Thiazide-like)

Ex: Indapamide

Profils croisés : indications phares et vigilance

CLASSE	MÉCANISME	INDICATIONS PHARES (Cibles)	EFFETS INDÉSIRABLES (Vigilance)
IEC / ARA-II	Bloque l'angiotensine II / aldostérone.	 Insuffisance cardiaque, Post-infarctus, Diabète (Néphropathie).	 Toux sèche (IEC), Hyperkaliémie. Surveillance : Créatinine / Potassium.
Antagonistes Calciques (Amlodipine)	Vasodilatation périphérique.	 Efficacité vasculaire directe.	 Œdèmes des chevilles, Céphalées, Bouffées de chaleur.
Diurétiques (Thiazidiques)	Excrétion sodée.	 Traitement chronique de fond.	 Hypokaliémie, Acide urique (Crise de goutte), Déshydratation.

L'algorithme d'escalade thérapeutique



Idéalement en un seul comprimé
(Single Pill) à faible dose.

Étape 1 : Bithérapie Initiale

(IEC ou ARA-II) +
(Inhibiteur calcique OU
Diurétique).

Étape 2 : Trithérapie

IEC ou ARA-II +
Inhibiteur calcique +
Diurétique.

Étape 3 : HTA Résistante

Ajout de Spironolactone
(25–50 mg/j).

Condition : Uniquement si l'eGFR (≥ 30) et la
kaliémie (≤ 4.5) sont compatibles.

Avant l'Étape 3 : Toujours exclure la mauvaise observance, l'effet blouse blanche, et l'HTA secondaire.

Le déclassement ciblé : le nouveau rôle des bêtabloquants

Ils ne sont plus le 1^{er} choix systématique dans une HTA essentielle non compliquée.

Maladie coronaire /
Angor / Post-infarctus

Insuffisance cardiaque

Fibrillation atriale
(Contrôle de fréquence)

Certaines situations
de grossesse



DANGER REBOND : Ne jamais arrêter brutalement un bêtabloquant chez un patient coronarien (Risque de tachycardie, infarctus).

La ligne de fracture clinique : Urgence ou non ?

Une pression de 180/110 seule ne définit PAS une urgence vitale.
L'organe fait l'urgence, pas le chiffre.

HTA SÉVÈRE SANS ATTEINTE

Scénario : PA 200/110, patient stable, asymptomatique.



Action : Calmer, confirmer, reprendre/adapter le traitement oral.



Interdit : PAS de baisse parentérale brutale.

URGENCE HYPERTENSIVE VRAIE

Scénario : PA $\geq 180/110$ + Atteinte aiguë d'organe (AVC, OAP, SCA, Dissection).



Action : Prise en charge hospitalière.

Antihypertenseurs IV titrables.

Gestion de l'urgence vraie : titration et cibles

Objectif Global : Ne pas normaliser. Baisse contrôlée (~20-25% max initialement) pour éviter l'hypoperfusion.

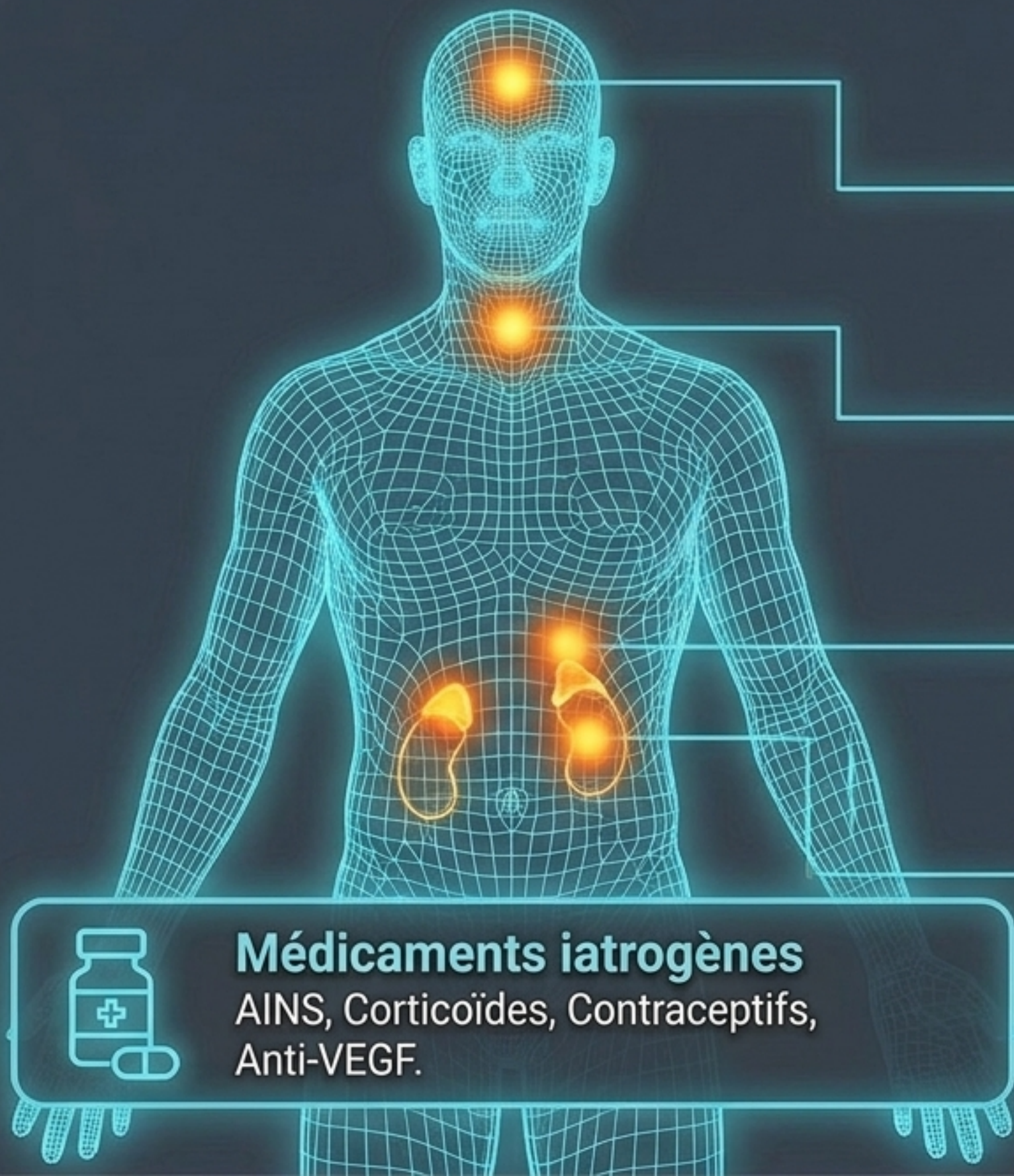


À BANNIR : Nifédipine immédiate (gouttes/sublinguale).

Chute trop rapide et imprévisible = Risque majeur de syncope, ischémie ou AVC.

La traque de l'HTA secondaire (Les signaux d'alerte)

Quand chercher ? HTA jeune, brutale, résistante, ou hypokaliémie.



SAOS (Apnée du sommeil)

Obésité, ronflements, absence de baisse nocturne.

Troubles Thyroïdiens

Hyperthyroïdie (PAS élevée) / Hypothyroïdie (PAD élevée).

Surrénales (Conn & Phéochromocytome)

Hypokaliémie spontanée / Triade : Céphalées, sueurs, palpitations.

HTA Rénovasculaire

Détérioration rénale brutale sous IEC/ARA-II.



Médicaments iatrogènes

AINS, Corticoïdes, Contraceptifs, Anti-VEGF.

Synthèse clinique : les 3 paramètres à retenir



La Cinétique prime sur le Chiffre.

L'HTA n'est pas une photo, c'est un film. Méfiez-vous c'est un film. Méfiez-vous de l'effet blouse blanche ; exigez des élévations persistantes confirmées par MAPA ou automesure.



L'Algorithme Simplifié.

La fondation est hygiéno-diététique.
Le traitement pharmacologique débute par une bithérapie (IEC/ARA-II + CCB/Diurétique), favorisée en un seul comprimé pour l'observance.



Le Piège de l'Urgence.

Ne traitez pas le tensiomètre. Traitez le patient. S'il n'y a pas S'il n'y a pas d'atteinte aiguë d'un organe cible, une baisse parentérale brutale est inutile et dangereuse.